Sono un corpo o possiedo un corpo?

Dalla persona intera alle ragioni della cura e del dono

Materiale ad uso personale dello studente

Il 29 agosto 2000 Giovanni Paolo II parla a un congresso internazionale dedicato ai trapianti. Si rivolge a persone che lavorano in un campo in cui una parte del corpo di qualcuno può aiutare un altro a vivere. Il papa riconosce il valore di questa possibilità. Ma nel suo discorso compare una frase che sposta l'attenzione dall'operazione a chi dona.

Che cosa passa da una persona all'altra

> *Non si dona semplicemente qualcosa di proprio, si dona qualcosa di sé.*
>
> Giovanni Paolo II, Discorso al 18° Congresso internazionale della Società dei Trapianti, 29 agosto 2000, n. 3 [1]

La differenza è piccola nelle parole e grande nel significato. Se regalo una giacca, consegno una cosa che possiedo. Chi la riceve può usarla senza che questo cambi la relazione con il mio corpo. Quando invece parliamo della donazione di un organo, quella parte non è stata soltanto conservata da qualche parte: appartiene alla vita corporea di una persona. Per capire il gesto non basta conoscere che cosa passa da un organismo all'altro. Bisogna sapere chi offre, per quale ragione, in quali condizioni, e se quella scelta è libera.

Consideriamo soprattutto la donazione dopo la morte. Una persona può esprimere in vita la volontà che il proprio corpo aiuti qualcun altro quando lei sarà morta. Il Catechismo cattolico incoraggia questo gesto a precise condizioni. Non lo considera un disprezzo del corpo. Proprio qui nasce il problema: come si può rispettare il corpo e nello stesso tempo permettere che una sua parte venga donata? Per rispondere dobbiamo capire che cosa significa dire il mio corpo. [2]

Nel dono di un organo è coinvolta una persona, non soltanto una cosa che cambia proprietario. Se ci dimentichiamo della persona, possiamo commettere due errori opposti: considerare il corpo un materiale a disposizione di chi ne ha bisogno, oppure considerarlo qualcosa che non può mai essere toccato, neppure per curare. La risposta cattolica cerca una strada che permetta la cura e il dono senza perdere nessuno dei soggetti coinvolti. Non dobbiamo scegliere adesso se vorremmo donare: dobbiamo capire le ragioni di questa risposta.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Il caso storico ha confini precisi

Il 29 agosto 2000 Giovanni Paolo II parla al diciottesimo Congresso internazionale della Società dei Trapianti. Il discorso non racconta un'operazione particolare: non parla di un paziente, di una sala operatoria o di un esito clinico. Il papa valorizza i trapianti e distingue possibilità tecnica e liceità morale, poi lega dono, rifiuto del commercio e consenso. Giovanni Paolo II, discorso del 29 agosto 2000, nn. 1–3.

Il corpo che posso osservare e il corpo che vivo

Cominciamo da un gesto molto più semplice. Una persona alza la mano per salutare un amico. Possiamo descrivere il movimento del braccio, le articolazioni, i muscoli coinvolti. Sono descrizioni vere e utili. Ma se ci fermiamo lì, sappiamo che un braccio si è mosso senza avere ancora detto che cosa quella persona stava facendo: riconosceva qualcuno e lo salutava. Il saluto non avviene accanto al movimento, in un altro luogo. Si esprime attraverso quel movimento. Questo è un esempio costruito per ragionare, non il racconto di un episodio del congresso.

La riflessione filosofica distingue così il corpo osservato e il corpo vissuto. Il primo è quello che possiamo misurare e studiare. Il secondo è il corpo di cui faccio esperienza in prima persona: sento freddo, mi avvicino a qualcuno, esprimo un rifiuto o una disponibilità. Non ci sono due corpi. Cambia la prospettiva con cui considero lo stesso essere umano. Il corpo che gli altri possono osservare è anche il corpo con cui io vivo e incontro gli altri.

Questa distinzione aiuta a capire anche una visita medica. Conoscere un valore misurato è indispensabile; sapere che cosa la persona comprende e teme è un'altra informazione necessaria per accompagnarla. Nessuna delle due rende inutile l'altra. Una spiegazione rispettosa non ripara da sola una lesione. Una tecnica efficace non ascolta da sola una domanda. La cura richiede persone competenti che sappiano tenere insieme queste esigenze.

Dire che il corpo è mio non è dunque sbagliato. Esprime il fatto che riguarda me in un modo che non riguarda gli oggetti della stanza. Ma la parola mio cambia significato quando la applico a una penna e quando la applico alla mia mano. Posso separarmi da una penna senza separarmi da una parte della mia esistenza corporea. Nella mano con cui scrivo, saluto o chiedo aiuto sono coinvolto io. D'altra parte, non sono riducibile all'elenco delle misure del mio corpo: ho una storia, relazioni, progetti che quelle misure, da sole, non raccontano.

Gli esempi di parlare, salutare e scegliere non sono un esame per stabilire chi merita rispetto. Chi oggi non può compiere un gesto o esprimere una decisione non diventa meno persona. Servono a riconoscere un'unità, non a classificare gli esseri umani in base alle prestazioni. Altrimenti, proprio mentre diciamo di considerare tutta la persona, finiremmo per misurarne il valore con una sola capacità. [3]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Pensiamo a che cosa cambia quando si passa da un oggetto a un interlocutore. Di una sedia posso chiedermi soltanto se sostiene bene il peso. Davanti a una persona non posso fermarmi alla funzione che mi serve. Il suo valore non dipende dall'utilità che può avere per me. Questo vale anche quando il bisogno di un altro è urgente: il bisogno merita una risposta, ma non trasforma chi potrebbe aiutarlo in una risorsa da prendere. [3]

CORPO VISSUTO
È il corpo con cui percepisco e agisco in prima persona, attraverso cui mi trovo nel mondo e incontro altri. Non è un secondo corpo immateriale: corpo osservabile e vissuto sono due prospettive sul medesimo essere umano. La fenomenologia la esprime in tedesco con due parole, *Körper* e *Leib*.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Una persona intera

La fede cattolica descrive questa unità con parole proprie. Un testo del Concilio Vaticano II, la costituzione Gaudium et spes, presenta l'essere umano come:

> *Unità di anima e di corpo.*
>
> Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 14 [4]

Non dice che il corpo sia un contenitore nel quale sia stato collocato il vero individuo. Non dice neppure che basti conoscere l'organismo per avere esaurito la persona. Anima e corpo indicano dimensioni distinte di un unico essere umano. Quando la tradizione parla dell'anima come principio che dà forma al corpo, forma non significa il contorno visibile. È un modo filosofico di dire che non siamo due esseri accostati: quello che vive, sente, pensa e agisce è una persona. [5]

Non stiamo cercando un organo minuscolo e invisibile chiamato anima. Un esame medico cerca dati sul funzionamento dell'organismo; qui stiamo esponendo una concezione filosofica e teologica dell'essere umano. Sono domande con metodi diversi. L'esperienza del corpo vissuto aiuta a capire perché una descrizione della persona non si esaurisca in una misura, ma non diventa per questo una dimostrazione sperimentale dell'anima. Si può comprendere questa distinzione anche senza condividere la fede. [5]

Il Concilio spiega inoltre perché un cristiano debba considerare il corpo buono e degno di onore: perché è creato da Dio ed è destinato alla risurrezione. La speranza cristiana non consiste nel liberarsi finalmente di un materiale senza valore. Riguarda la persona intera. Anche l'Incarnazione, cioè la fede che il Figlio di Dio sia diventato veramente uomo, impedisce di trattare il corpo come una presenza indegna di Dio. Sono ragioni interne alla fede cristiana, non risultati di un laboratorio. [4]

Per la fede cattolica, il corpo partecipa al valore della persona perché è parte della sua unità con l'anima. Da questa convinzione viene un criterio morale: chi interviene sul corpo deve chiedersi che cosa sta facendo a quella persona. Non basta poter eseguire un'operazione, e non basta voler ottenere un risultato utile. Bisogna vedere se il modo scelto custodisce il bene di chi la subisce. Il criterio non dice di lasciare il corpo sempre com'è. Dice di curarlo proprio perché il suo bene riguarda qualcuno. [6]

L'anima e il livello dell'affermazione

L'unità non cancella la distinzione fra dimensione corporea e spirituale. La Commissione Teologica Internazionale, in *Comunione e servizio* (n. 30), richiama l'anima come forma sostanziale: principio per cui corpo e anima costituiscono un singolo essere umano. Il termine forma non significa sagoma visibile e l'anima non è un organo aggiuntivo. La stessa Commissione propone un'analogia con l'informazione biologica e ne segnala il limite: può far confondere concetti metafisici e dati biologici. Il n. 29 collega il corpo alla creazione, all'Incarnazione e alla risurrezione: questi sono i motivi cristiani del suo valore, non prove sperimentali. L'unità della persona non significa che si debba essere sempre in grado di parlare, agire o decidere per possedere dignità.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Curare qualcuno

Supponiamo un caso d'esempio, con i dati già stabiliti: una parte malata dell'organismo mette in pericolo la vita di un adulto; non esistono alternative meno lesive efficaci; l'intervento offre un beneficio proporzionato ai rischi e il paziente, informato, acconsente. Non tocca a noi diagnosticare la malattia: assumiamo questi elementi soltanto per capire il ragionamento morale. Rimuovere quella parte danneggia materialmente l'integrità del corpo, ma può essere il modo necessario per salvare la persona. La morale cattolica chiama questo criterio principio di totalità, o principio terapeutico. [7]

Il tutto di cui si parla è l'organismo di quello stesso paziente. La parte malata viene trattata per il bene della persona cui appartiene. Non si sta dicendo che una persona possa essere sacrificata perché un gruppo ne avrebbe vantaggio. Un reparto non è un unico organismo nel quale qualcuno sia un pezzo disponibile per qualcun altro. Questa differenza sarà decisiva quando torneremo al dono.

Nel nostro caso abbiamo nominato anche il consenso. Perché conta, se il medico conosce meglio la terapia? Perché conoscere una cura non significa diventare proprietario della vita di chi la riceve. Nel rapporto ordinario che stiamo considerando, il paziente deve poter comprendere la proposta, i benefici attesi, i rischi e le alternative, per esprimere una scelta. La firma può documentare questa decisione, ma non crea da sola la comprensione. Se qualcuno firma senza avere capito, manca proprio ciò che il consenso informato dovrebbe proteggere.

Per decidere, il malato ha bisogno anche della verità sulla propria situazione, comunicata con parole comprensibili e attenzione alla sua paura. Ingannarlo per tranquillizzarlo gli toglierebbe la possibilità di scegliere consapevolmente. Curare una parte del corpo significa prendersi cura della persona intera, rispettando anche la sua comprensione e la sua scelta.

La scelta libera, però, non basta da sola a rendere buona qualunque proposta. Consideriamo una sperimentazione ipotetica: una persona accetta per aiutare futuri malati, ma i rischi cui verrebbe esposta sono sproporzionati ed evitabili. La sua intenzione è generosa; il suo assenso non elimina il problema. Il Catechismo ammette il valore della ricerca e chiede insieme consenso e rispetto dell'integrità della persona. La domanda morale riguarda ciò che si fa, il motivo per cui lo si fa e le condizioni concrete: una buona intenzione non trasforma automaticamente un'azione dannosa in un'azione giusta. [8]

L'obiezione è seria: se la ricerca può aiutare molte persone, porre un limite non rischia di ostacolarla? La risposta non consiste nel negare il valore del progresso. Chiede che quel progresso non venga pagato trattando qualcuno come materiale sperimentale. Una ricerca al servizio degli esseri umani deve includere fra le persone da rispettare anche chi vi partecipa oggi, non soltanto chi potrebbe beneficiarne domani. Il limite nasce dallo stesso fine che rende preziosa la ricerca. [8]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

> **PRINCIPIO DI TOTALITÀ**
> Il bene della persona intera può giustificare un intervento sulla parte malata o causa diretta del pericolo, a condizioni proporzionate e con consenso. La totalità in questa applicazione è quella dello stesso paziente; non è la somma di tutti i pazienti di un ospedale.

Consenso e verità

Nel caso ordinario l'adulto è capace di comprendere e decidere e non c'è emergenza. Il consenso è un processo di informazione comprensibile e decisione libera, non il solo segno grafico della firma. La verità al malato è condizione della scelta consapevole: si comunica in modo comprensibile e attento alla paura, senza ingannare per tranquillizzare. L'informazione riguarda completezza, alternative, rischi e modi di comunicarli. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 2295, pone due condizioni distinte: consenso e rispetto della persona con rischi proporzionati.

Donare senza usare una persona

Torniamo allora al dono. Chi offre sangue per aiutare qualcuno non sta necessariamente rimuovendo una parte malata del proprio organismo. La ragione del gesto è diversa dalla terapia del primo caso: è la solidarietà verso un'altra persona. Anche qui consideriamo un esempio ipotetico: l'idoneità è stata valutata dai sanitari, i rischi sono proporzionati e la decisione è informata e libera. Sono dati dell'esempio, non una valutazione sulle condizioni di qualcuno di noi. [9]

La distinzione è importante: il bene di chi riceve non assorbe quello di chi dona. I due rimangono persone diverse. La Nuova Carta degli operatori sanitari distingue proprio il principio di totalità, riferito a interventi sulla stessa persona, dalla solidarietà che rende comprensibile il dono a un'altra. La possibilità di aiutare non cancella il dovere di proteggere chi aiuta. [9]

Dopo la morte la situazione è diversa: non siamo più davanti a un soggetto vivente, ma il corpo che rimane non diventa materiale senza valore. È il corpo della persona che è morta; per la fede cristiana va onorato anche nella speranza della risurrezione. Il Catechismo chiede rispetto per il corpo dei defunti e nello stesso tempo ammette la donazione gratuita degli organi. Il rispetto non impone che ogni organo rimanga intatto: chiede che il dono rispetti chi è morto e la volontà espressa in vita. [10]

Resta una condizione decisiva. Per il prelievo di organi vitali singoli, il discorso di Giovanni Paolo II pone come condizione che la morte sia già avvenuta e sia accertata: non si può provocare la morte di qualcuno per salvare qualcun altro. L'accertamento richiede competenza medica e procedure rigorose, che qui non sono trattate. Il principio morale indica il limite; non sostituisce chi deve verificare i dati. [10]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Si può ora comprendere la frase iniziale. Se il corpo fosse soltanto un oggetto, potremmo pensare al dono come a uno spostamento di materiale utile. Se invece ogni intervento fosse una mancanza di rispetto, non sapremmo spiegare il valore della cura. Considerare il corpo parte della persona consente di chiedere quale intervento la serva e quale la usi. Il dono può aiutare un'altra persona proprio perché rispetta la persona che dona.

La risposta al titolo, dunque, richiede di precisare le parole. Ho un corpo nel senso che posso averne cura e assumere decisioni che lo riguardano. Sono corporeo nel senso che non vivo fuori da esso, come un proprietario esterno: attraverso il corpo incontro, agisco, ricevo aiuto e posso offrirlo. Per la fede cattolica sono una persona, unità di anima e corpo. È per questo che il rispetto del corpo può prendere la forma di una terapia e anche di un dono, purché la vita e la libertà di chi è coinvolto restino al centro del gesto.

Due persone, non un solo organismo

La *Nuova Carta degli operatori sanitari* distingue al n. 112 il trapianto sulla stessa persona, giustificato dalla totalità, dal trapianto tra persone al n. 113, legato alla solidarietà. Questo impedisce il falso ragionamento per cui il bene del ricevente autorizzerebbe a sacrificare il donatore come una parte subordinata di un organismo collettivo. Nel dono dopo la morte vanno rispettati la volontà espressa e il corpo del defunto. Il n. 114 della Nuova Carta distingue il cadavere umano, sempre da rispettare, dal soggetto vivente: il corpo morto non ha la stessa condizione della persona viva. Il Catechismo, al n. 2300, fonda il rispetto anche nella fede e nella speranza della risurrezione; al n. 2301 ammette il dono gratuito degli organi dopo la morte.

Il corpo è parte della persona, perciò curarlo o donarlo richiede di custodire insieme la vita e la libertà di chi è coinvolto, senza trattare nessuno come un oggetto.

Fonti

[1] Giovanni Paolo II, Discorso al 18° Congresso internazionale della Società dei Trapianti, 29 agosto 2000, n. 3

[2] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 2296

[3] Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio (2004), nn. 22 e 31

[4] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 14

[5] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), n. 365

[6] Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio (2004), nn. 82–85

[7] Commissione Teologica Internazionale, Comunione e servizio (2004), nn. 83–85

[8] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), nn. 2292–2295

[9] Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, Nuova Carta degli operatori sanitari (2016), pp. 94–96, nn. 111–114

[10] Catechismo della Chiesa Cattolica (1992, ed. tipica 1997), nn. 2300–2301

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati